

SEMANA 8

CONSOLIDACIÓN 8

DESARROLLO EMBRIOFETAL NORMAL Y PATOLÓGICO. SU EVALUACIÓN.

Para reafirmar lo estudiado en este tema te proponemos analices y respondas los siguientes ejercicios.

1. Teniendo en cuenta las características del período fetal, escriba en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

- a) ___ El período fetal se caracteriza por un marcado aumento de la talla y el peso.
- b) ___ Es la etapa de mayor susceptibilidad para la aparición de malformaciones congénitas.
- c) ___ Se produce la maduración de los sistemas y órganos.
- d) ___ La piel se cubre de lanugo y vérnix caseosa.
- e) ___ Se inicia la formación del líquido amniótico.
- f) ___ Se pueden palpar los movimientos fetales.
- g) ___ Existe un crecimiento desproporcionado de la cabeza con respecto al cuerpo.

2. Relacionado con las malformaciones congénitas y el diagnóstico prenatal selecciona la respuesta correcta en cada caso marcando con una X.

- a) Las malformaciones congénitas aparecen con mayor frecuencia en el:
 - a) ---- Periodo preembrionario.
 - b) ---- Periodo embrionario.
 - c) ---- Periodo fetal.
- b) Los medicamentos como la amitriptilina y la warfarina producen malformaciones congénitas y estos se consideran agentes de naturaleza:
 - a) ---- Química
 - b) ---- Física
 - c) ---- Infeccioso
- c) Las malformaciones congénitas se producen por radiaciones y altas temperaturas, que son agentes de naturaleza:
 - a) ---- Química
 - b) ---- Física
 - c) ---- Infeccioso

- d) Para el diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas puede ser útil:
 - a) ---- La determinación de alfafetoproteína en el suero materno.
 - b) ----- Determinación de gonadotropina coriónica en orina.
 - c) ---- La radiografía abdominal
- e) Las malformación congénita se produce por la acción del virus de la rubéola y el SIDA que son considerados agentes de naturaleza:
 - a) ----Química
 - b) ---- Física
 - c) ---- Infecciosa

3. Argumenta la repercusión que sobre el desarrollo del embrión pueden producir las siguientes situaciones. Valora posibles medios diagnósticos en cada uno de los casos.

- a) Mujer embarazada con mola hidatiforme.
- b) Presencia de bridas amnióticas.
- c) Alteración cromosómica fetal.
- d) Embarazo gemelar.

4. A tu consulta como médico integral comunitario acude una paciente de 32 años de edad, fumadora crónica con antecedentes de 2 cesáreas a causa de presentar placenta previa central y de padecer de hipertensión arterial severa durante la gestación. Actualmente se encuentra embarazada con 12 semanas de edad gestacional y asiste a consulta por estar preocupada por el bienestar de su futuro hijo. ¿Qué explicación le ofrecerías acerca de su preocupación, valorando los riesgos y las posibles soluciones?

5. Se realiza un ultrasonido a una embarazada de 23 años de edad, con bajo peso y talla, que tiene 28 semanas de edad gestacional. En el informe emitido se constata feto único de sexo masculino, que presenta un peso bajo para su edad, poco desarrollo del cráneo, volumen de líquido amniótico de 150 ml y la placenta presenta un grado de maduración avanzado en correspondencia a la edad gestacional. Interpreta los hallazgos del estudio ultrasonográfico a partir de su evaluación, explicando las repercusiones favorables o adversas de los determinantes del desarrollo y el crecimiento fetal presentes en este caso.

6. A tu consulta como médico integral comunitario acude una paciente de 20 años de edad, con antecedentes de padecer de Diabetes Mellitus insulino dependiente desde hace 5 años y se le

diagnóstica embarazo de 8 semanas. Ante el diagnóstico emitido, la paciente refiere estar preocupada por el bienestar de su futuro hijo. ¿Qué explicación le ofrecerías valorando los riesgos y las posibles soluciones?

7. Una embarazada de 45 años de edad con antecedentes familiares de Síndrome de Down y malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central, acude con su pareja en busca de información sobre los medios diagnósticos para evaluar la posible presencia de defectos genéticos y cromosómicos en el embrión-feto. Ofréceles una explicación acerca de los posibles medios diagnósticos a utilizar para evaluar la presencia de defectos genéticos y cromosómicos en el embrión-feto en embarazadas de alto riesgo.

8. Una paciente de 14 años de edad, acude a tu consultorio por presentar un fuerte dolor en la espalda, acompañado de fiebre y tos intensa. Luego de realizar el examen físico se le indicó y se le realizó una radiografía de tórax para comprobar una posible infección respiratoria. Al realizar el diagnóstico, se le orienta ingerir 2 tabletas de tetraciclina cada 6 horas durante 10 días, acompañada de aspirina y abundantes líquidos. Dos semanas después, ella asiste nuevamente al consultorio por presentar amenorrea (falta de menstruación), situación que le preocupa por la posibilidad de estar embarazada y que el tratamiento y el proceder médico recibido afecten a su futuro hijo.

- a. ¿Qué explicación le darías a esta paciente sobre la preocupación que motiva su nueva asistencia a consulta?
- b. Interpreta los posibles defectos del desarrollo que pueden producir los agentes teratógenos en este caso.
- c. Orienta tres medidas a esta paciente para prevenir posibles alteraciones congénitas. Argumenta.

9. Valora la repercusión de los determinantes sobre el crecimiento y el desarrollo embrio-fetal en las siguientes situaciones:

- a. Mujer de 28 años edad, con un embarazo de 6 semanas y antecedentes obstétricos de 2 partos distócicos (fórceps) y 3 abortos espontáneos, epiléptica grado II tratada con anticonvulsivantes orales, de bajo peso y talla, fumadora (más de 20 cigarrillos diarios) e ingiere bebidas alcohólicas regularmente dos veces por semanas.
- b. Adolescente de 12 años de edad, con antecedentes familiares de Sickleemia (anemia de células falciformes), se le diagnostica embarazo gemelar de 12

semanas. En los exámenes de laboratorio se constata anemia de 7,6 gramos por litro y aumento considerable de la glicemia.

10. A tu consulta acude una mujer de 30 años de edad, con dependencia al alcohol y a la cocaína, que se le diagnostica embarazo de 8 semanas. Ante el diagnóstico emitido, la paciente refiere estar preocupada por el bienestar de su futuro hijo. ¿Qué explicación le ofrecerías valorando los riesgos y las posibles soluciones?

11. Sobre el desarrollo fetal normal o patológico escriba en el espacio en blanco una (V) si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

- a) ☐ El crecimiento en longitud del feto ocurre fundamentalmente durante el tercer, cuarto y quinto mes.
- b) ☐ El crecimiento rápido de la cabeza es característico del período fetal.
- c) ☐ Los movimientos fetales son percibidos por la madre durante el quinto mes.
- d) ☐ La maduración insuficiente del sistema nervioso central y del sistema respiratorio afectan la supervivencia del feto si el nacimiento es antes de séptimo mes.
- e) ☐ Los síndromes son producidos por bandas amnióticas.
- f) ☐ El virus de la rubéola es un agente teratógeno que puede producir catarata congénita, glaucoma, defectos cardíacos y sordera.
- g) ☐ La diabetes materna puede producir defectos cardíacos y del tubo neural.
- h) ☐ El consumo de alcohol y cocaína son determinantes adversos al crecimiento y desarrollo fetal.
- i) ☐ Las manifestaciones del desarrollo anormal por acción de un agente teratógeno depende de la dosis y el tiempo de exposición al mismo.

12. Mencione los principios básicos de la teratología.

13. Mencione los diferentes procedimientos médicos que permiten una evaluación del crecimiento y desarrollo fetal y el diagnóstico prenatal.

14. Varias malformaciones han sido asociadas con determinados teratógenos, con relación a este tema relaciona las malformaciones de la columna A con el teratógeno correspondiente en la columna B.

Columna A	Columna B
a) ___ Cataratas, sordera, glaucoma.	1. Diabetes.
b) ___ Amelia y meromelia.	2. Alcohol.
c) ___ Defectos cardiacos, disgenesia caudal,	3. Virus de la rubéola.
	4. Talidomida.